

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Cuestionario Breve de Evitación Experiencial (BEAQ-15)

Eje II • Versión verificada y operativa con protocolo cotejado (Vázquez-Morejón et al., 2019)

1. Identificación y Referencias Oficiales

Nombre	Cuestionario Breve de Evitación Experiencial (Brief Experiential Avoidance Questionnaire)
Sigla	BEAQ-15
Autores originales	Gámez, W., Chmielewski, M., Kotov, R., Ruggero, C., & Watson, D. (2014)
Adaptación española	Vázquez-Morejón, R., León Rubio, J. M., Martín Rodríguez, A., & Vázquez-Morejón, A. J. (2019). <i>Psicothema</i> , 31(3), 336-341. DOI: 10.7334/psicothema2019.60
Eje temático	EJE II – Procesos Psicológicos y Mecanismos de Mantenimiento
Constructo evaluado	Evitación experiencial (renuencia a permanecer en contacto con vivencias internas desagradables)
Población y muestra	Población clínica adulta ($N = 332$ pacientes en tratamiento ambulatorio en España; edad 18-65 años, $M = 36.19$, $DE = 12.01$)
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme (tiempo estimado: 3 minutos)
Acceso y licencia	Acceso abierto (Psicothema / Creative Commons)

2. Estructura y Sistema de Puntuación

Número de ítems	15 ítems bilingües verificados en el apéndice del artículo fuente (pág. 338)
Formato de respuesta	Escala Likert de 6 puntos: 1 = Totalmente en desacuerdo a 6 = Totalmente de acuerdo
Regla de puntuación	Todos los ítems puntúan de forma directa (1 a 6), excepto el Ítem 6 que es invertido: Puntuación Ítem 6 = 7 - Respuesta (1=6, 2=5, 3=4, 4=3, 5=2, 6=1). Puntuación total = suma de los 15 ítems (rango posible: 15 a 90 puntos).
Ítems invertidos	Ítem 6: “El miedo o la ansiedad no me impedirán hacer las cosas importantes” (Fear or anxiety won’t stop me from doing something important). Refleja aceptación y disposición hacia la acción.
Baremos clínicos	Muestra clínica española ($N = 332$): Media = 55.60, $DE = 13.92$ (similar a muestras clínicas del original en inglés: $M = 56.41$ y 52.03). Puntuaciones elevadas indican mayor rigidez y evitación experiencial.

3. Evidencia Psicométrica en España (Vázquez-Morejón et al., 2019)

- **Consistencia interna:** $\alpha = .82$ (idéntico a la muestra clínica original de Gámez et al., $\alpha = .83$).
- **Fiabilidad test-retest:** $r = .70$ ($p < .01$) tras 4 a 6 semanas de intervalo (demostrando estabilidad temporal del rasgo).
- **Estructura factorial:** Modelo unifactorial explica el 30.12% de la varianza total (primer autovalor = 4.52).
- **Validez convergente y discriminante:** Correlación robusta con la Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II: $r = .67$, $p < .01$) y correlaciones moderadas con el SCL-90-R (promedio $r = .39$), confirmando la discriminación frente al neuroticismo o malestar general.

4. Trazabilidad de QA y Archivos en Carpeta

Activos disponibles	• Protocolo.pdf: Formulario autoadministrado de 1 página listo para aplicación clínica. • Articulo_Validacion_VazquezMorejon2019.pdf: Artículo completo de validación en <i>Psicothema</i> (6 págs.). • Ficha_Tecnica.docx / Ficha_Tecnica.pdf: Ficha técnica institucional v1.1. • Fuente_y_uso.md: Registro de procedencia y trazabilidad de derechos.
Estado del protocolo	presente_verificado — 15 ítems, regla de inversión del ítem 6 y baremo clínico confirmados.